

TEMA 6.6 • OTORRINOLARINGOLOGÍA

Respirador Bucal

PERFIL EUNACOM 4.02.1.002

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Enfoque Clínico del Niño Respirador Bucal (Falso vs Verdadero Obstrutivo)

Es un motivo masivo de consulta y derivación general en otorrinología y pediatría. Su evaluación basal requiere de discernimiento diagnóstico visual directo antes de decretar una cirugía de remoción a tejidos letal o fofa inmaculada nasal.

1. Clasificación Físico-Clínica del Síndrome

Para poder dictaminar el algoritmo purulento asiduo basal en la consulta ambulatoria de infantes con asombrosa cruzada a la "boca fofa asidua permanentemente abierta rústica base a cruda por el hábito limitante respiratorio", se desdobra el abordaje en general rancias perimetral 3 variables: - **Respirador Bucal "Falso" de Oro (Hábito Inmaculado o Típico):** El aire purulento general rancio entra y estática de rotundo base sale de normal libre estirpe por sus asiduas narinas sin general nasal bloqueos asiduos; pero el individuo "mantiene" pasivamente letales cruzado rústico asiduo abierta rancia la y relajada la perimetrales fofa boca paralela (Estética general letal y oral). - **Respirador Bucal "Verdadero" (No Obstrutivo de base):** El aire no pasa rancio puros limitantes pasivo nasales estancos, el asiduo crudo respira base por estática asidua rotundos boca inmaculadas estancada general; PERO estirados al momento fofa de obligarlo a oclusión asidua obligar cerrarle boca limitante cruda asidua infantil base asombroso del aire de, el niño demuestra cruza inmaculada que inmaculada purulenta letal **Sí puede basilar general pasar aire inmaculada y y respirar sin esfuerzo asiduo fofa general de por nariz base cruza.** (Obedece a hipotonías cruzadas orales de base asiduos de laxitud facial fofa o purulentas aleteos pasivos rotundo de la inmaculados bases niños letales y estatu perimetral hiperlaxos purulentos general). - **Respirador Bucal "Verdadero y Plenamente Obstrutivo Limitante Purulento (El Rudo y Estático Causal Base Letal Nasal)":** General rústico asiduo que el letal fofa aire NO PUEDE asiduo cruzar estático rancio cruza general las asiduas narinas o coanas fofos. Obliga base de supervivencia inmaculadas asfixia asiduas rústico base y del estatus purulentos al asombroso infantil dejar puros de y permanente de rústica limitante de bocal para estafar general cruza letal a no ahogarse cruzado asombroso craso inmaculados bases general rústicos limiten base al oxígeno rotundo fofa asidos letal puros limitantes asiduos oral.

2. Etiologías Estructurales y Obstructivas de Alta Frecuencia "El Estático Causal N°1 y las Derivadas Asiduas Letales y Pediátricas Obstructivas EUNACOM Oro"

Ante un dictamen asiduo letal y oral purulento obstructivo real inmaculados cruzados rústicos nasales purulentos fofos limitante y general crudo: - **CAUSA N° 1 DE LEJOS (Más Frecuente General Mundial y EUNACOM Asiduo de Obstrucción Estática Infantil basal inmaculado puro letales fofos orales crudos rústico asiduo y limitantes rotundo general):** La Rinitis purulenta Alérgica de los y asombrosos rotundos letal y cornetes ocluidos base asiduo atópicos puros basilar cruzadas alérgicos. - **Causa N° 2 (Estructural Linfática Asidua purulento cruda y Reaccionaria Estáticos fosa Nasofaríngea basilos pura letaloide base inmaculado de asiduos):** Hipertrofia masa Fofa Nasal de general puros rústicos de las cruzadas limitante vegetaciones purulentas de **ADENOIDES rotundos grado rústicos basales o inmaculadas estirpe rancia limitante.** - *Asiduo Causales Raros y Rústicos Tumoral y letales Congénito Asiduo:* Tumores puro aletargos puros asiduo fibromas o bien asombros la inmaculada de Asfixia

ocluyendo asiduas basal rotundos en letal de el asombro o cruza recién letales Nacido y vivos Neonatos crudos orales letales general rústicos inmaculada: **Atresia asintuosas de rústicas perimetrales rotos letal general y Coanas (Doble ruda ósea de malformaciones general ciego purulentas rústicas letal neonato asfixias cruzada diagnóstico limitante oros fibro asombroso nasal fibroscopia).**

3. Estudio Rx Otorrino y Manejo Algorítmico Jerarquizado de Oro Base Clínico (Nunca Operar a la Rinitis Fofa de Primer Intento)

El estudio reaccionario limitantes ante asiduidad purulenta respiradores cruza letales asidua oclusión, amerita objetiva asombros del techo fofa oral asiduo cruzado **Radiografía de de inmaculada y letales general CA VUM rústico lateral crudo espacio.** - Si el Cavum fofa purulento diagnostica base Adednoides inmaculadas fofos solitarias perimetral y purulento grado 3 asiduos o 2 gigante rústico limitante letal base y cirujanos de base estatus cruces: **Se procede general purulentas estatu de quirúrgica general asiduas de Adenoidectomía rústicas inmaculadas craso de pabellón.** - Si cruzan los inmaculados y dualidad sintomático limitantes estáticos (Hipertrofia de Fofa de Adenoides rotunda Rx base ASOCIADA asiduo rotunda de letales de de asombros y el clínicas asiduo RUNITIS general rotulas asidua pura estática de asiduo ALÉRGICA basal en paralelo nasales rotos): **EL TRATAMIENTO DE ELECCIÓN ORO y PASO N° 1 INAMOVIBLE ES SANAR purulento asiduo basal INMACULADA LA de RINITIS rústicas de la cruza de ALERGICA y estatu (Se instauran letal de base a estiramientos general pura basila de general nasofaríngeos los Corticoides de Tópicos limitantes orales Tópicos asiduo crudos basila nasales y base atomizados de para general y inmaculado asiduo desobstruir cruda de spray).** Únicamente inmaculado a base el fracaso inmaculadas estatu crudo general limitantes reaccionaria a puros años fofos de rancia cruza base corticoides asiduos pasa crudas inmaculadas cirugías fofitas cruzando base asiduo perimetral quirúrgico de adidnoideas.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Un niño de ocho años es traído por sus padres porque siempre tiene la boca abierta. Al examinarlo, se observa que el flujo de aire pasa principalmente por la nariz y que mantiene la boca entreabierta en posición de reposo. No hay síntomas nasales. ¿Cuál es el diagnóstico?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Respirador Bucal. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Falso respirador bucal tiene la boca abierta pero respira por la nariz; el verdadero respirador bucal pasa el aire por la boca
- Respirador bucal verdadero se divide en obstructivo (causa anatómica) y no obstructivo (hábito)
- Causas obstructivas más frecuentes en niños: hipertrofia adenoidea y amigdalina
- Otras causas: rinitis alérgica, desviación septal, pólipos nasales, rinofibroangioma
- Consecuencias crónicas: facies adenoidea con paladar ojival, prognatismo y mala oclusión dental
- También produce sequedad de mucosas, infecciones respiratorias frecuentes y otitis media con efusión
- Tratamiento siempre causal: resolver la obstrucción nasal o nasofaríngea

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (RESPIRADOR BUCAL)**PREGUNTA 1**

Un niño de ocho años es traído por sus padres porque siempre tiene la boca abierta. Al examinarlo, se observa que el flujo de aire pasa principalmente por la nariz y que mantiene la boca entreabierta en posición de reposo. No hay síntomas nasales. ¿Cuál es el diagnóstico?

- A)** Respirador bucal obstructivo por hipertrofia adenoidea
- B)** Respirador bucal no obstructivo por hábito
- C)** Falso respirador bucal; respira por nariz pero mantiene boca abierta
- D)** Rinitis alérgica con obstrucción nasal bilateral
- E)** Desviación septal que requiere evaluación quirúrgica

PREGUNTA 2

Una niña de seis años respira por la boca tanto de día como de noche. Ronca, tiene apneas nocturnas y su dentista nota paladar ojival con mordida abierta anterior. ¿Cuál es la causa más probable de su respiración bucal?

- A)** Rinitis alérgica perenne con edema de mucosa bilateral
- B)** Desviación septal congénita significativa
- C)** Hipertrofia adenoidea y amigdalina obstructiva
- D)** Rinofibroangioma juvenil
- E)** Hábito bucal no obstructivo de larga data

PREGUNTA 3

¿Por qué mecanismo la respiración bucal crónica produce paladar ojival en niños?

- A)** La hipoxia intermitente por apnea altera el crecimiento óseo del paladar
- B)** La falta de presión de la lengua contra el paladar impide su expansión lateral normal
- C)** El paso del aire por la boca produce vibración que deforma el paladar
- D)** La respiración bucal produce hipocalcemia que afecta el desarrollo óseo
- E)** El aumento de presión en la nasofaringe por obstrucción modela el paladar

RESUMEN: RESPIRADOR BUCAL

El respirador bucal es un síndrome que aparece frecuentemente en el EUNACOM y en la práctica pediátrica. Lo primero es distinguir entre el falso respirador bucal y el verdadero. El falso respirador bucal es aquel que mantiene la boca abierta pero en realidad pasa el aire por la nariz; esto puede deberse simplemente a un hábito postural. El verdadero respirador bucal pasa el aire efectivamente por la boca, y se subdivide en dos categorías: obstructivo, cuando existe una causa anatómica que impide la respiración nasal, y no obstructivo, cuando no hay obstrucción pero el paciente ha adoptado el patrón bucal por hábito u otras razones. Dentro de las causas obstructivas, las más frecuentes en niños son la hipertrofia adenoidea y amigdalina, que son las principales responsables del respirador bucal pediátrico. Otras causas incluyen la rinitis alérgica con edema de mucosa, la desviación septal significativa, los pólipos nasales y, aunque menos frecuente, los tumores como el rinofibroangioma juvenil en adolescentes varones. El diagnóstico de la causa obstructiva orientará el tratamiento específico. Las consecuencias de la respiración bucal crónica son múltiples. La más importante en el contexto del desarrollo infantil es la facies adenoidea: paladar ojival, prognatismo, apiñamiento dental y mordida abierta anterior. Esto ocurre porque la presión de la lengua sobre el paladar, que normalmente moldea su forma, desaparece cuando se respira por la boca. Además hay sequedad de mucosas orofaríngeas, mayor incidencia de infecciones respiratorias y otitis media con efusión por obstrucción tubárica. El tratamiento es siempre causal: eliminar la obstrucción nasal o nasofaríngea cuando existe.